

Rastra — Pontos para Consulta com a PMAL

Preparado para: próxima reunião com o Coronel Raumário / representantes da PMAL **Data de preparação:** 24/08/2026 (atualizado em 30/08/2026)

Este documento reúne exclusivamente as questões que **dependem de resposta ou decisão da PMAL** — levantadas ao longo do desenvolvimento do projeto — para serem tratadas na próxima reunião. Pontos que são decisão interna da equipe Rastra não estão listados aqui.

1. Estrutura de Comando e Hierarquia

1.1 Hierarquia multinível do painel de comando O painel de indicadores agregados precisa refletir visões separadas por Batalhão, Companhia e Pelotão desde o início do piloto, cada uma restrita ao efetivo daquela unidade — ou um único nível de comando é suficiente para os 30 dias iniciais? Adicionalmente: essa hierarquia deveria ser livremente configurável pelo Gerente/comandante de cada unidade dentro do próprio sistema, ou precisa corresponder a uma estrutura oficial fixa, que não pode ser alterada localmente sem autorização de nível superior?

1.2 Papel da Junta Policial Militar de Saúde dentro do sistema Já identificamos, no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas (Lei nº 5.346/1992), que a **Junta Policial Militar de Saúde** — nome oficial, não “Junta Médica” — atua em situações específicas: homologação de incapacidade temporária que leva à reforma (Art. 54), retorno ao serviço de policial reformado por incapacidade (Art. 57), parecer para licença por doença de pessoa da família (Art. 100), e definição/prorrogação de licença para tratamento de saúde própria (Art. 101). O que ainda precisa de definição: qual é, na prática, o papel dessa Junta dentro do sistema Rastra neste piloto — ela participa desde já, ou fica de fora do escopo dos 30 dias iniciais?

1.3 Composição mínima varia por tipo de caso? A composição da Junta Policial Militar de Saúde (quantidade de membros, quem participa) muda dependendo do motivo da avaliação — por exemplo, uma licença de saúde própria de rotina (Art. 101) exige menos formalidade que uma homologação de incapacidade permanente para reforma (Art. 54)? Ou a PMAL trata todo caso com a mesma composição, independentemente do motivo?

1.4 Regulamento de composição da Junta Localizamos o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 5.346/1992), que confirma a existência e as funções legais da Junta Policial Militar de Saúde, mas **não detalha sua composição interna** (presidência, secretaria, mandato rotativo, participação de médicos civis) — essa informação veio apenas de explicação verbal do Coronel. Existe um regulamento ou decreto específico que descreva essa composição com precisão? Se existir, seria muito útil ter acesso a ele para modelar o sistema com exatidão.

2. Formato do Piloto

2.1 Participação voluntária ou obrigatória O piloto inicial deveria ser opt-in/voluntário, com um grupo reduzido de integrantes, ou obrigatório para todo o efetivo do batalhão desde o primeiro dia?

2.2 Ordem de sensibilidade dos dados Nossa recomendação é iniciar com dados de menor sensibilidade (desempenho físico, TAF) antes de incluir dados clínicos mais sensíveis, para construir confiança gradualmente com o efetivo participante. Essa priorização faz sentido do ponto de vista da PMAL, ou existe preferência diferente?

2.3 Validação do ranking com opt-out A ideia de ranking de avaliações físicas (sugerida pelo Coronel) será implementada com nome visível aos colegas, mas com a opção de cada integrante decidir não aparecer (opt-out individual) — para preservar autonomia sobre o próprio dado. Essa mitigação é aceitável, ou a PMAL prefere outro formato?

3. Jurídico e Contratação

3.1 Viabilidade do CPSI Existe uma modalidade de licitação simplificada — o Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI), previsto na Lei Complementar nº 182/2021 — voltada à testagem de soluções inovadoras pela administração pública antes de um contrato de fornecimento pleno. O setor jurídico/de licitações da PMAL tem experiência prévia ou abertura para avaliar esse instrumento?

3.2 Prazo de retenção de documentos/laudos Qual é o prazo de guarda legal hoje aplicado aos laudos e pareceres

da Junta Policial Militar de Saúde (em papel/processo físico)? Precisamos replicar a mesma regra de retenção no sistema quando esse tipo de dado passar a ser armazenado digitalmente.

3.3 Base legal para tratamento de dado de saúde Para fins de conformidade com a LGPD, qual base legal a PMAL pretende adotar formalmente para o tratamento do dado de saúde no sistema — tutela da saúde, cumprimento de obrigação legal/regulatória, ou outra prevista no art. 11 da lei?

4. Apoio Técnico e Validação de Conteúdo

4.1 Revisão das tabelas de referência clínica Solicitamos a indicação de um profissional do Corpo de Saúde da PMAL para revisar, junto com a equipe Rastria, as tabelas de referência clínica utilizadas na verificação automática de exames e os critérios de aprovação do TAF, antes do início do piloto.

5. Formalização

5.1 Carta de intenção Como próximo passo formal da colaboração, propomos a assinatura de uma carta de intenção (sem caráter contratual ou financeiro), registrando o interesse mútuo em avançar com o piloto.

6. Novas Funcionalidades em Avaliação

6.1 Conexão com aplicativos pessoais de atividade física (ex: Strava) Estamos avaliando permitir que o integrante conecte, de forma opcional, uma conta pessoal de aplicativo de atividade física (ex: Strava) para importar dados de exercício físico — sempre como informação complementar no histórico pessoal, nunca contando para o ranking ou para qualquer avaliação oficial (diferente do TAF, que continua sendo presencial e institucional). Existe alguma restrição institucional da PMAL quanto a policiais conectarem contas pessoais de aplicativos de terceiros a um sistema corporativo, mesmo de forma opcional e não obrigatória?

Documento de uso interno da equipe Rastria para preparação de reunião. Pode ser adaptado para compartilhamento direto com a PMAL, conforme necessidade.